

回肠膀胱（回肠流出道）

WARWIKI

患者须知 · 将尿液引流至造口袋的尿路改道手术

回肠膀胱是膀胱切除或失去功能后引流尿液的一种方式。医生利用您自身的一小段回肠，将肾脏产生的尿液引流至腹部的小开口（造口），尿液随即流入一个轻便的造口袋中。这是最简单、最常见的尿路改道方式。

关于这项手术

手术截取一段约 **15–20 厘米的回肠**作为**通道** — 它不储存尿液。输尿管（从肾脏引出的管道）与该肠段相连，一端经腹壁引出形成**造口**，通常位于腹部右下方。由于尿液**持续**流出，您需要在造口处佩戴轻便的造口袋，每天清空数次，每隔几天更换一次。

- **无需手动控制，也无需导尿。**
- 其余肠段**重新吻合**，消化功能正常进行。
- **造口护士**会指导您如何护理造口和造口袋。

安全吗？

回肠膀胱作为非可控性尿路改道手术已有70余年历史，手术步骤最简单、时间最短。与所有大手术一样，存在出血、感染、肠道或输尿管吻合口漏等风险。远期可能出现造口或皮肤问题、尿路感染或电解质/维生素改变，均在随访中监测。

名词解释

尿路改道

膀胱缺失或失去功能时，让尿液排出体外的新通道。

回肠膀胱（回肠流出道）

一小段回肠，将尿液引流至造口。

造口

腹部由肠管形成的小开口，尿液由此排出。

造口袋

佩戴在造口处用于收集尿液的袋子（器具）。

输尿管

从肾脏输送尿液的管道，与回肠导管相连。

造口护士

负责标记造口位置并指导造口及造口袋护理的护士。

黏液

肠道分泌的滑液，尿液中出现丝状黏液属正常现象。

造口周围皮肤

造口周围的皮肤，需保持清洁并做好保护。

会疼吗？ 手术在全身麻醉下进行，过程中不会有任何感觉。术后腹部会有酸痛感，肠道需要几天才能“苏醒”（从流质饮食开始逐步过渡）。造口本身没有痛觉。大多数患者住院约5至7天。

如何准备（术前）

- 手术在**全身麻醉**下进行 — 遵照所有术前指示（禁食及停用相关药物，包括抗凝药）。可能需要**肠道准备**。
- 提前拜访**造口护士**，由其在您坐位、站位和卧位时标记最佳造口位置 — 这对佩戴舒适、防止渗漏至关重要。
- **请勿吸烟** — 吸烟会减慢愈合 — 并安排好术后在家的照护支持。

请提前告知医疗团队以下情况：

- 正在服用**抗凝药**，或目前存在感染
- 有**肠道疾病**（如克罗恩病或结肠炎）、腹部手术史或放疗史

手术过程

- 1 全身麻醉入睡后，给予抗生素。
- 2 截取一小段回肠备用，其余肠段重新吻合。
- 3 将两侧输尿管与该肠段相连。
- 4 将肠段一端经腹壁引出形成造口；放置软支架管和引流管，待愈合。

之后

- 约**5至7天**后出院。造口护士将指导您**清空造口袋**（每天数次）及**更换器具**（每隔几天一次）。
- 尿液中出现**黏液**属正常现象 — 由肠道分泌。
- **多喝水**，并做好造口周围皮肤的护理。
- 约**6周内避免重体力活动**。需终身定期复查（肾功能、维生素B12）。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 发热或寒战
- 造口颜色**变暗、发青或向内凹陷**
- 数小时内造口袋中**几乎没有或完全没有尿液**
- 剧烈腹痛、呕吐，或**无排气、无排便**（肠道不通）
- 大量出血，或伤口红肿、渗液

需要记住的三件事

1. 回肠膀胱利用一小段回肠将尿液引流至腹部造口，再流入造口袋 — 是最简单的尿路改造方式，无需导尿。
2. 术前准备：遵照禁食和肠道准备指示，拜访造口护士进行造口标记，戒烟，并安排家庭照护支持。
3. 尿液中出现黏液属正常现象，造口护士会指导造口袋护理和皮肤护理。如出现发热、造口变色、造口袋无尿液或腹部无排气排便，请立即就医。